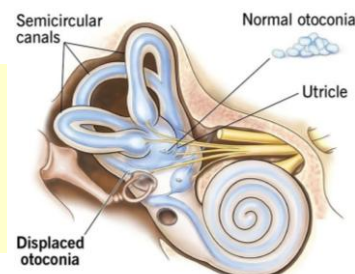


ΙΛΙΓΓΟΣ

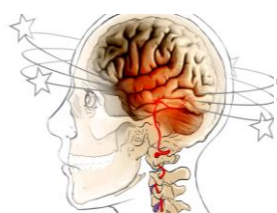
Γενικά: Ελέγχουμε, αρχικώς, αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο ίλιγγου ή για υποτροπή. Τα συμπτώματα του **καλοήθους παροξυσμικού ίλιγγου θέσεως (ΚΠΙΘ)** συνήθως διαρκούν λίγα λεπτά, υποτροπιάζουν για μερικές ημέρες ή εβδομάδες, στη συνέχεια εξαφανίζονται, αλλά πιθανώς να επανέλθουν, μετά από κάποιο διάστημα, με την ίδια ή όχι κλινική εικόνα. Ελέγχουμε, επίσης, αν πρόκειται για περιφερικής ή κεντρικής αιτιολογίας ίλιγγο.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ

- Αιφνίδια εμφάνιση του επεισοδίου ίλιγγου.
- Εξαντλούμενος νυσταγμός. Οριζόντιος νυσταγμός, συνήθως.
- Ο ασθενής αδυνατεί να σταθεί όρθιος ή να βαδίσει.
- Έντονα συμπτώματα από το αυτόνομο (έμετοι, ναυτία, εμβοές).
- Αίτια: ΚΠΙΘ, Meniere, νευρωνίτιδα, λαβυρινθίτιδα, φάρμακα.



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ



- Προοδευτική εισβολή και επιμονή του επεισοδίου ίλιγγου.
- Μη εξαντλούμενος νυσταγμός. Οριζόντιος και κάθετος νυσταγμός.
- Πιθανή ύπαρξη διπλωπίας, δυσαρθρίας ή συμπτωμάτων από το ΚΝΣ.
- Ιστορικό (πιθανώς) ελαφράς ΚΕΚ ή άλλης βλάβης του ΚΝΣ.
- Ήπια συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα.
- Αίτια: αγγειακά, πολλαπλή σκλήρυνση, ΑΕΕ, όγκοι, φάρμακα.

Κλινική εξέταση: Διερευνούμε αρχικώς, εάν πρόκειται για ΚΠΙΘ ή για ίλιγγο άλλης αιτίας [π.χ. αιθουσαία νευρωνίτιδα, λαβυρινθίτιδα, νόσος Meniere, κατάχρηση αλκοόλ, φάρμακα (αμινογλυκοσίδες, cisplatin, σαλικυλικά, διουρητικά), ιογενή αίτια (π.χ. VZV-Ramsay Hunt), ΑΕΕ, χολοστεάτωμα και σπανιότερα από όγκους ή ΑΚΘ του οπισθίου κρανιακού βόθρου]. Στον ΚΠΙΘ τα συμπτώματα διαρκούν για μερικά λεπτά, ενώ στην οξεία λαβυρινθίτιδα, την αιθουσαία νευρωνίτιδα και σε σοβαρότερες παθήσεις μπορεί να διαρκούν αρκετές ημέρες.

Ο ΚΠΙΘ είναι μια κατάσταση που προκαλεί έντονη ζάλη και ίλιγγο, συνήθως κατά την αλλαγή της θέσης της κεφαλής. Έτσι, συχνά αναφέρεται ότι το απότομο ανασήκωμα από το κρεβάτι ή το στριφογύρισμα και η απότομη αλλαγή θέσης κατά τον ύπνο προκάλεσε έντονη ζάλη και ίλιγγο. Εκδήλωση ζάλης, αστάθειας και ίλιγγου, συχνά παρουσιάζεται μετά από την απότομη κίνηση της κεφαλής προς τα πίσω ή επάνω. Επίσης, σε αρκετές γυναίκες με ζάλη και ίλιγγο, τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από επίσκεψη σε κομμωτήριο, όπου το λούσιμο και το στέγνωμα των μαλλιών επιτυγχάνεται σε θέση υπερέκτασης της κεφαλής ή στους ελαιοχρωματιστές κατά το πολύωρο βάψιμο της οροφής κτηρίων.

Πολύτιμες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από την ακρόαση των καρωτίδων, όπου σε περίπτωση στενώσεως γίνεται αντιληπτό φύσημα. Επίσης, θα πρέπει να δοκιμαστεί και η περιστροφή του αυχένος, για να ελεγχθεί η πιθανότητα συμπίεσης της σπονδυλικής αρτηρίας από μετατόπιση σπονδύλων, ειδικά σε ιστορικό κακώσεως της ΑΜΣΣ.

Αδρή νευρολογική εξέταση: Έλεγχος και εκτίμηση των βασικών οφθαλμικών κινήσεων, όπως ο αυτόματος αιθουσαίος και οπτοκινητικός νυσταγμός και οι σακκαδικές κινήσεις. Φωτοκινητικό αντανάκλαστικό, δοκιμασία Romberg. (Είναι χρήσιμη στην οξεία μονόπλευρη αιθουσαία διαταραχή – παρέκκλιση στην πάσχουσα πλευρά. Δεν θεωρείται όμως ειδική στις χρόνιες μονόπλευρες διαταραχές). Ο «χειρισμός Dix-Hallpike» επάγει ίλιγγο και μια έξαρση νυσταγμού, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα ως προς την κατεύθυνσή του, που επιτρέπουν την εντόπιση της πλευράς ή και του ίδιου του ημικύκλιου σωλήνα που έχει προσβληθεί.

Ο ασθενής με επιμένοντα ίλιγγο θα πρέπει να υποβληθεί - σε εύλογο χρόνο - σε έλεγχο με Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών, καθώς και σε CT ή/και MRI εγκεφάλου. Μπορεί, παράλληλα, να κριθεί αναγκαία η διενέργεια εκλεκτικής ψηφιακής αγγειογραφίας (DSA), όπως στη σπονδυλοβασική ανεπάρκεια ή στο σύνδρομο υποκλοπής της υποκλειδίου αρτηρίας ή σε υποψία στένωσης, θρόμβωσης ή διαχωρισμού των καρωτίδων αρτηριών.

Θεραπευτική παρέμβαση

A. Σε περιφερικό ίλιγγο:

1. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή με 500 ml NaCl 0,9% κι εντός αυτού 3 amp. Πιρακετάμη (*Nootrop/Oxynium 1 gr*) σε συνεχή στάγδην έγχυση για 30-60 λεπτά, καθώς επίσης και 1 amp. Πιρακετάμη iv-bolus (η χορήγησή της αντενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό αιμορραγιών, επί λήψεως αντιπηκτικών ή αντισταμοπεταλιακών παραγόντων και σε ΧΝΑ).
2. Ενίουμε 1 amp. Vomex-A (im), (προσοχή σε ασθενείς με άσθμα, γλαύκωμα, ΚΥΠ, κ.ά.).
3. Χορηγείται Σιμετιδίνη (1-2 amp. *Tagamet*) & 1 amp. Primperan ή 1 amp. Onda (iv ή im).
4. Όσο διαρκεί η θεραπεία, αφήνουμε τον ασθενή να ξεκουραστεί, με χαμηλό φωτισμό.

B. Σε κεντρικό ίλιγγο:

1. Χορηγούμε ½ - 1 amp. Stedon 10 mg (im) ή 1 amp. σε 250 ml N/S (iv), σε 20-30 λεπτά.
2. Σε ίλιγγο που συνοδεύεται από εμβοές ώτων, χορηγούμε 3 amp. Nootrop σε 500 ml N/S σε στάγδην έγχυση, σε 30-60 λεπτά (η χρησιμότητα της Πιρακετάμης αμφισβητείται).
3. Μπορεί να χορηγηθεί 1 caps. Κινναριζίνη (*Stugeron forte*) 75 mg (po), ως δόση εφόδου.

Γ. Θεραπεία κατ' οίκον:

Φάρμακα που καταστέλλουν την ναυτία είναι συχνά χρήσιμα, για την άμεση καταστολή του ίλιγγου (μαζί με υγιεινή διατροφή και ενυδάτωση) και συστήνονται από πολλούς, αλλά καταλείπουν τελικά ένα αίσθημα καρηβαρίας, αστάθειας ή ανισορροπίας. Έτσι, χορηγούμε:

- ✓ Dimenhydrinate/B3/B6 (*Vertigo-Vomex*), caps. (120/75/30) mg, 1x2, για 5-7 ημέρες, ή
- ✓ Dimenhydrinate (*Vomex-A*), supp. 100 mg 1x2 έως και 1x4 (po), για 5 ημέρες, ή
- ✓ Cinnarizine (*Stugeron forte*), caps. 75 mg, 1x1 (po), για 5-7 ημέρες.
- ✓ Cinnarizine/Dimenhydrinate (*Vertigo-N*), tab. (20/40 mg) mg, 1x3, για 5-7 ημέρες.
- ✓ Betahistine (*Antivom/Ribrain*), tab. 8 mg 1x2 ή 16 mg 1x1 (po), για 7-14 ημέρες, ή (Προσοχή: εάν ο ασθενής έχει ιστορικό γαστροπάθειας, μεριμνούμε για γαστροπροστασία, ενώ αντενδείκνυται σε παιδιά, εγκύους και σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα ή φαιοχρωμοκύττωμα).
- ✓ Meclozine (*Emetostop*), tab. 30 mg, 1x3 για 3-5 ημέρες (χορηγείται και στην κύηση).

Αρκετά αποτελεσματική θεωρείται η εφαρμογή μιας σειράς ασκήσεων και χειρισμών, που στόχο έχουν να μετακινήσουν, να διαλύσουν ή ακόμα και να επανατοποθετήσουν τους ωτόλιθους στην αρχική θέση τους. **Οι ασκήσεις και οι χειρισμοί Epley και Semont** έχουν μεγάλη επιτυχία, μέχρι και στο 80% των ασθενών. Στόχο έχουν να μετακινήσουν τους ωτόλιθους από τη θέση εκείνη που προκαλεί έκλυση του ίλιγγου, δηλαδή από τον οπίσθιο κάθετο ημικύκλιο σωλήνα. Αν οι παραπάνω χειρισμοί αποτύχουν, τότε προτείνονται από πολλούς **οι ασκήσεις του Hamid**, που περιγράφονται στην κάτωθι εικόνα και συνιστάται να εκτελούνται 10 επαναλήψεις με κλειστά και με ανοιχτά μάτια, τρεις φορές την ημέρα.

Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν ή υποτροπιάζουν, παραπέμπουμε σε εύλογο χρόνο, σε ειδικό ιατρό (ΩΡΛ), για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του ασθενούς.

